Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Entfernung der Unterkieferspeicheldrüse

Entfernung der Speicheldrüse unter dem Kiefer (Glandula submandibularis)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Seite: ☐ Rechts ☐ Links

Grund der Operation: ☐ Speichelstein / wiederkehrende Entzündung ☐ Knoten in der Drüse ☐ Sonstiges _____

Neuromonitoring: ☐ Wird eingesetzt ☐ Wird nicht eingesetzt

Ergebnis der Bildgebung / Biopsie: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Die Unterkieferspeicheldrüse (Glandula submandibularis) ist eine Speicheldrüse, die auf jeder Seite knapp unterhalb des Unterkiefers liegt und Speichel in den Mund abgibt. Sie bildet einen erheblichen Teil des Speichels; da jedoch die Drüse der Gegenseite sowie die Speicheldrüsen vor den Ohren und unter der Zunge weiterarbeiten, **führt die Entfernung einer Drüse bei den meisten Patienten nicht zu Mundtrockenheit**.

Diese Operation wird am häufigsten wegen **Speichelsteinen** und der dadurch verursachten **wiederkehrenden Schwellungen und Entzündungen** durchgeführt. Ein Stein behindert den Abfluss des Speichels in den Mund; dadurch kommt es beim Essen zu schmerzhaften Schwellungen unter dem Kiefer und zu wiederholten Infektionen. Seltener macht ein **Knoten (Tumor)** in der Drüse eine Operation erforderlich. Der Anteil bösartiger Tumoren ist bei Knoten der Unterkieferspeicheldrüse höher als bei Knoten der Ohrspeicheldrüse; die Entfernung der Drüse und ihre feingewebliche Untersuchung sind daher für eine endgültige Diagnose wichtig.

In der Nähe der Drüse verlaufen drei Nerven: der Nervenast, der die Unterlippe bewegt, der Nerv, der die Zunge sensibel versorgt (Gefühl), und der Nerv, der die Zunge bewegt. Ziel der Operation ist es, die Drüse unter Erhalt dieser Nerven vollständig zu entfernen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in Vollnarkose im Operationssaal durchgeführt.

1. **Hautschnitt:** Etwa 2–3 cm unterhalb des Unterkieferknochens wird parallel zu einer natürlichen Hautfalte des Halses ein meist 4–6 cm langer Schnitt angelegt. Ein ausreichend tief unterhalb des Kiefers gesetzter Schnitt hilft, den Nervenast zu schützen, der die Unterlippe bewegt.
2. **Schutz der Nerven:** Die dünne Muskelschicht unter der Haut (Platysma) wird durchtrennt. Der Nervenast, der die Unterlippe bewegt (Ramus marginalis mandibulae), wird geschützt – entweder indem er dargestellt wird oder indem in einer sicheren Gewebeschicht präpariert wird.
3. **Entfernung der Drüse:** Die Drüse wird vom umgebenden Gewebe gelöst, und die versorgenden Blutgefäße werden unterbunden. Der Speichelgang wird sorgfältig von dem Nerv getrennt, der die Zunge sensibel versorgt (Nervus lingualis), und anschließend unterbunden und durchtrennt. Der Nerv, der die Zunge bewegt (Nervus hypoglossus), wird geschont. Befindet sich ein Stein im Gang, wird auch der weiter entfernte Teil des Gangs so weit wie möglich mit entfernt.
4. **Feingewebliche Untersuchung:** Die entfernte Drüse wird zur Pathologie geschickt; das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 1–2 Wochen vor.
5. **Wundverschluss:** Blutungen werden gestillt, meist wird eine dünne **Drainage** eingelegt, und die Haut wird mit kosmetischen Nähten verschlossen.

Befindet sich ein Stein im Mund nahe der Mündung des Gangs, kann er manchmal zusätzlich separat vom Mund aus entfernt werden. Dies wird vor der Operation mit Ihnen besprochen.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 1–2 Stunden	In der Regel 1 Nacht; Entlassung nach Entfernung der Drainage

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Ende der wiederkehrenden schmerzhaften Schwellungen und Entzündungen durch Steine
- Keine wiederholten Antibiotikabehandlungen mehr erforderlich
- Entfernung eines Knotens in der Drüse und Stellung der endgültigen Diagnose

Nach einer Operation wegen Steinen und chronischer Entzündung verschwinden die Beschwerden bei **mehr als 90 %** der Patienten vollständig. Verbleibt ein Stein in dem im Mund belassenen Teil des Gangs oder bildet sich dort ein neuer, kann selten eine Schwellung des Mundbodens fortbestehen. Bei gutartigen Knoten führt die Operation meist zur dauerhaften Heilung; bösartige Tumoren können eine weitere Behandlung erfordern.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Medikamentöse und unterstützende Behandlung:** Reichlich Flüssigkeit, saure Geschmacksreize zur Anregung des Speichelflusses, Massage, warme Umschläge und Antibiotika während Entzündungsphasen. Dies kann die Beschwerden lindern, beseitigt den Stein jedoch nicht.
- **Entfernung des Steins vom Mund aus:** Tastbare Steine im mundnahen Teil des Gangs können über einen kleinen Schnitt im Mund entfernt werden; die Drüse bleibt dabei erhalten.
- **Spiegelung des Speichelgangs (Sialendoskopie):** Steine geeigneter Größe und Lage können mit einem feinen Endoskop aus dem Gang entfernt werden; dies wird nicht in jedem Zentrum angeboten und ist nicht für jeden Stein geeignet.
- **Beobachtung:** Bei kleinen Knoten, die für gutartig gehalten werden, kann in seltenen Fällen eine Beobachtung besprochen werden; bei dieser Drüse wird jedoch zur Sicherung der Diagnose in der Regel eine Operation empfohlen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation können Schwellungen und Entzündungen durch Steine immer wieder auftreten; selten kann sich um die Drüse ein Abszess (Eiteransammlung) bilden, der eine Notfallbehandlung erfordert. Besteht ein Knoten in der Drüse, kann keine endgültige Diagnose gestellt werden; ein unbehandelter bösartiger Tumor kann fortschreiten.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen und eine Bildgebung (Ultraschall, bei Bedarf CT/MRT) durchgeführt; Sie werden von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht.
- In den **6–8 Stunden** vor der Operation dürfen Sie nichts essen und nichts trinken (bitte befolgen Sie die Anweisungen der Narkoseärztin bzw. des Narkosearztes).
- Ist die Drüse akut entzündet, wird die Operation in der Regel erst nach Behandlung der Entzündung geplant.
- Bei männlichen Patienten kann der Bart im Schnittbereich am Operationstag gekürzt werden.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 24–48 Stunden	Unter dem Kiefer bestehen leichte bis mäßige Schmerzen, ein Spannungsgefühl und eine Schwellung, die mit Schmerzmitteln behandelt werden. Das Schlucken kann etwas unangenehm sein. Die Drainage wird meist am 1. Tag entfernt. Es wird empfohlen, mit erhöhtem Kopf zu schlafen. Mit weicher Kost können Sie sofort beginnen.
1. Woche	Sie können Ihren Alltagstätigkeiten wieder nachgehen. Die Fäden werden in der Regel am **5.–7. Tag** gezogen. Ein Taubheitsgefühl oberhalb des Schnitts, entlang des Kieferrands und rund um den Schnitt ist normal. Das Ergebnis der Pathologie wird in diesem Zeitraum oder kurz danach mit Ihnen besprochen.
2.–4. Woche	Die meisten Patienten können innerhalb von 1 Woche wieder einer Bürotätigkeit nachgehen. Anstrengender Sport und schweres Heben sollten etwa **2 Wochen** aufgeschoben werden. Verhärtung und leichte Schwellung im Schnittbereich nehmen allmählich ab.
2.–6. Monat	Die Narbe verblasst allmählich und ist in der Halsfalte oft kaum noch zu sehen. Eine eventuelle vorübergehende Nervenschwäche oder ein vermindertes Gefühl bildet sich meist in diesem Zeitraum zurück.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Schmerzen, Spannungsgefühl und Schwellung unter dem Kiefer; leichte Beschwerden beim Schlucken
- Taubheitsgefühl der Haut um den Schnitt und unterhalb davon
- Eine Narbe am Hals (verblasst mit der Zeit)

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Vorübergehende Schwäche der Unterlippe** — Durch Zug an dem Nervenast, der die Unterlippe nach unten zieht (Ramus marginalis mandibulae), während der Operation zeigt sich bei etwa **10–20 von 100** Patienten beim Lächeln oder Sprechen eine leichte Asymmetrie der Unterlippe auf dieser Seite. Es handelt sich um ein kosmetisches Problem, das Essen und Trinken in der Regel nicht beeinträchtigt und sich meist **innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten bessert**.
- **Verhärtung und Taubheitsgefühl im Schnittbereich** — Verhärtung und vermindertes Gefühl unterhalb des Schnitts sind in den ersten Wochen häufig und nehmen im Laufe von Monaten ab.

Gelegentliche Beschwerden

- **Nachblutung und Bluterguss (Hämatom)** — Bei etwa **1–3 von 100** Patienten kann sich Blut unter der Haut ansammeln. Ist die Ansammlung groß, muss sie unter Umständen im Operationssaal ausgeräumt und die Blutung gestillt werden.
- **Wundinfektion** — Kann bei **1–3 von 100** Patienten auftreten, besonders wenn die Drüse entzündet war; sie heilt meist mit Antibiotika ab, selten ist eine Eiterentleerung (Drainage) erforderlich.
- **Vermindertes Gefühl auf einer Zungenseite** — Durch eine Beeinträchtigung des Nervs, der die Zunge sensibel versorgt (Nervus lingualis), treten bei etwa **1–3 von 100** Patienten Taubheit oder Kribbeln auf dieser Zungenseite auf. Dies ist meist vorübergehend; selten kann es dauerhaft sein und auch den Geschmackssinn beeinträchtigen.
- **Flüssigkeitsansammlung (Serom)** — Ansammlung von Flüssigkeit unter dem Schnitt; klingt meist durch Punktion mit einer Nadel und einen Druckverband ab.
- **Im Gang verbliebener Stein** — In dem im Mund belassenen Teil des Speichelgangs kann ein Stein verbleiben oder sich neu bilden und eine Schwellung oder Entzündung des Mundbodens verursachen. Bei Bedarf wird er mit einem kleinen Eingriff vom Mund aus entfernt.
- **Auffällige oder verdickte Narbe** — Je nach individueller Veranlagung kann sich die Narbe verdicken oder auffällig bleiben; Narbenbehandlungen können eingesetzt werden.
- **Einsenkung unter dem Kiefer** — An der Stelle der Drüse können eine leichte Mulde und ein Unterschied zwischen beiden Seiten entstehen; dies fällt meist nicht auf.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Dauerhafte Schwäche der Unterlippe** — Bei **etwa 1–3 von 100** Patienten oder weniger kann eine dauerhaft eingeschränkte Beweglichkeit der Unterlippe auf dieser Seite und ein asymmetrisches Lächeln zurückbleiben. Fällt dies deutlich auf, können Behandlungen wie Botulinumtoxin zum Ausgleich der Gegenseite eingesetzt werden.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Schwäche der Zungenbeweglichkeit** — Eine Verletzung des Nervs, der die Zunge bewegt (Nervus hypoglossus), ist **sehr selten**. Tritt sie auf, kann es zu einer Schwäche dieser Zungenseite sowie zu Schwierigkeiten beim Sprechen und Schlucken kommen; bei einer dauerhaften Schädigung kann eine Sprech- und Schlucktherapie erforderlich sein.
- **Großer Bluterguss am Hals mit Beeinträchtigung der Atemwege** — Sehr selten kann eine sich rasch vergrößernde Blutansammlung auf den Hals drücken und Schluck- oder **Atembeschwerden** verursachen. Dies ist ein Notfall: Sie muss sofort im Operationssaal ausgeräumt werden, und selten muss der Atemweg gesichert werden (Intubation oder Luftröhrenschnitt/Tracheotomie).
- **Endgültiger feingeweblicher Befund weicht von der vorläufigen Diagnose ab** — Selbst bei einer Drüse, bei der Steine oder eine Entzündung vermutet werden, kann der endgültige feingewebliche Befund einen unerwarteten Tumor zeigen. Wird ein bösartiger Tumor festgestellt, können weitere Behandlungen wie die Entfernung der Halslymphknoten oder eine Strahlentherapie erforderlich sein.
- **Mundtrockenheit** — Die Entfernung einer Drüse bleibt bei den meisten Patienten unbemerkt; bei Patienten, die eine Strahlentherapie erhalten haben, bestimmte rheumatische Erkrankungen haben oder Medikamente einnehmen, die Mundtrockenheit verursachen, kann eine Mundtrockenheit jedoch spürbar werden.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Rasch zunehmende Schwellung am Hals**, insbesondere mit **Atem- oder Schluckbeschwerden** (Notfall – rufen Sie sofort die 112 an)
- **Nicht aufhörende Blutung** aus der Drainage oder der Wunde
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Rötung, Schmerzen, Überwärmung oder Eiter aus der Wunde
- Deutliche Schwellung der Zunge oder des Mundbodens
- **Neu aufgetretene, deutliche Schwierigkeiten** beim Sprechen oder Schlucken

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Halten Sie die Wunde in den ersten 48 Stunden trocken; danach dürfen Sie nach Anweisung kurz duschen.
- Bevorzugen Sie in den ersten Tagen weiche, lauwarme Speisen; achten Sie auf eine gute Mundhygiene und trinken Sie reichlich.
- Schützen Sie die Narbe mindestens 6 Monate lang vor der Sonne (Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor).
- Besprechen Sie das Ergebnis der Pathologie und den Nachsorgeplan unbedingt mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).

☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.

☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.

☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.

☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.

☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.

☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.

☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.

☐ Ich habe verstanden, dass die endgültige Diagnose nach der Operation durch die Pathologie gestellt wird und dass je nach Ergebnis eine weitere Behandlung erforderlich sein kann.

☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**

☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein."

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.